Peritonitis, perforación y hemoperitoneo

SEMIOLOGIA · Clase 31 · abdomen en tabla y signo de Jobert

1 · QUÉ SE ROMPE Y QUÉ CAE A LA CAVIDAD

Antecedente ulceroso
50-70 % úlcera antigua o crónica · 25 % reciente · 7-10 % asintomática

en la mayoría precede a la

Úlcera péptica perforada
perfil típico: varón con úlcera duodenal (8 veces más que la gástrica; varón 4-5:1)

F5
Contusión abdominal
el golpe puede romper una víscera hueca

si rompe una víscera hueca causa la

al romperse produce la

F5
Víscera hueca perforada
sale jugo gástrico o duodenal y aire: contamina el peritoneo

según lo que cae define el

Qué cae decide el cuadro
jugo y aire = tabla · bacterias = peritonitis con shock · sangre = abdomen blando

2 · LA ÚLCERA PERFORADA: TRES FASES

Tres fases clínicas
química → mejoría aparente → bacteriana

a las 2-6 h sigue la

evoluciona en

comienza con la

el aire libre forma el

1 · Peritonitis química
dolor súbito en puñalada

2 · Mejoría aparente, 2-6 h
baja el dolor

el dolor impone una

Actitud del paciente
inmovilidad, respiración torácica y piernas flexionadas

y a la palpación muestra

F6
Abdomen en tabla
contractura difusa de toda la pared

es engañosa porque

la contractura sigue en la fase 2

Pero persisten
contractura y silencio abdominal

si no se opera, tras 12 h llega la

3 · Peritonitis bacteriana, más de 12 h
distensión, vómitos, fiebre >38 °C y oliguria

3 · AIRE LIBRE: JOBERT Y SEMILUNA

F3 · F10
Neumoperitoneo
el aire libre sube y queda entre el hígado y la pared, bajo el diafragma

solo si es hueca libera aire:

F10 · F11
Solo la víscera hueca tiene aire
por eso perder la matidez hepática orienta a ruptura de víscera hueca, no maciza

al percutir el hígado produce el

explica la pérdida de matidez del

F8 · F9 · F10 · F11
Signo de Jobert
desaparece la matidez hepática: timpanismo en el área hepática

puede simularse por

Falsos positivos de Jobert
enfisema o colon interpuesto

se ve en la

por eso se confirma con la

F3
Radiografía de pie
semiluna de neumoperitoneo bajo la cúpula derecha: lo que prueba la perforación (75-80 %, desde 1 cm³)

al confirmar la perforación indica

si no puede pararse, se toma en

Decúbito lateral izquierdo
si el paciente no puede pararse

4 · PERITONITIS: TABLA, SILENCIO Y SHOCK

Gérmenes frecuentes
E. coli, otros gramnegativos y anaerobios

colonizan el peritoneo en la

Peritonitis aguda difusa
colonización bacteriana del peritoneo

se manifiesta primero por la

inhibe el peristaltismo y da

el líquido que se pierde forma el

si se hace sistémica eleva la

igual conduce a la

F1 · F2 · F6
Defensa abdominal
el hallazgo más precoz

F4
Íleo paralítico
distensión y silencio abdominal (ausencia de ruidos hidroaéreos)

F4
Tercer espacio
el líquido sale de los vasos a la cavidad: deshidratación y hematocrito alto

FC >100 lpm
signo de mal pronóstico

se confirma con el

se evita con la

se produce por una

se acompaña de una

F6
Contractura refleja
los músculos de la pared protegen el peritoneo irritado: abdomen en tabla

F1 · F2
Signo de Blumberg
dolor al soltar la mano: confirma la irritación peritoneal

Presión baja y convergente

puede terminar en

se corrige con reposición y

contribuye al

Shock séptico

junto con el Blumberg forma el

se evita con la

si lo que cae son bacterias, da la

es una

si lo que cae es sangre, es el

5 · HEMOPERITONEO: DUELE PERO ESTÁ BLANDO

la pérdida de sangre da

F12
Signos de hemorragia
dolor súbito lancinante, palidez, taquicardia e hipotensión

la pérdida se mide con la

la sangre irrita poco: abdomen

F7
Abdomen flácido
la sangre irrita poco el peritoneo: muy doloroso pero sin contractura

sin contractura se confirma con la

la sangre acumulada da

F7
Matidez desplazable
líquido libre; ruidos disminuidos

el líquido libre se ve en la

bajo el diafragma da el

F12
Signo de Lafont
la sangre bajo el diafragma irrita el frénico: dolor en el hombro

apoya la

al tacto vaginal se encuentra el

F12
Douglas abombado
doloroso al tacto vaginal

se confirma con la

F12
Embarazo ectópico roto
la trompa se rompe y la sangre cae libre a la cavidad peritoneal (hemoperitoneo)

Ecografía y hemograma
líquido libre y anemia aguda

conduce a la

6 · QUÉ DECIDE OPERAR

F1 · F2
El examen físico decide
defensa, tabla y Blumberg bastan para indicar cirugía; ni Rx ni laboratorio son imprescindibles

basta para indicar la

Cirugía urgente
controla la perforación o la hemorragia y evita el shock

causa · mecanismo · concepto · síndrome · signo · complicación · diagnóstico · técnica · desenlace · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.° # de la lámina

Fuente: Tu teoría: 09f Abdomen agudo, 09b Exploración del abdomen y 09g Embarazo ectópico roto — teoría del docente